

17.1 Anatomie-Karte Atemwege

Format: A5

Obere Atemwege:

Nase/Mund → Rachen

Untere Atemwege:

Kehlkopf (Kehldeckel)

Luftröhre (Knorpelspangen)

Bronchien (re/li)

Lungenbläschen (Gasaustausch O₂/CO₂)

Steuerung:

Atemzentrum im verlängerten Rückenmark (unwillkürlich); willkürlich beeinflussbar

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018)

17.2 Atemnot-Erkennung — Quick-Check

Format: A5

AUF DEN ERSTEN BLICK:

- ☐ Sitzende Position, Arme abgestützt
- ☐ Ringen nach Luft
- ☐ Unnatürliche Atemgeräusche
- ☐ Zyanose (Lippen, Nagelbett)
- ☐ Angst, Unruhe

AUS DER ANAMNESE (SAMPLER):

- ☐ Bekannte Erkrankung (z. B. Asthma)
- ☐ Psychische Erregung
- ☐ Bewusstseinsstörung
- ☐ Hinweis auf Verletzung / Insektenstich

ATEMQUALITÄT:

- ☐ Frequenz (zu hoch / zu niedrig)
- ☐ Tiefe (flach / tief)
- ☐ Rhythmus (regelmäßig / unregelmäßig)

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018)

17.3 Atemkontrolle — Schritte

Format: A5

1. Mundraum-Kontrolle (Fremdkörper?)
2. Kopf in den Nacken beugen + UK vorziehen
3. Sehen – Hören – Spüren
(Hände am Kopf NICHT entfernen)
4. Dauer: max. 10 Sekunden
5. Keine normale Atmung → HLW

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018)

17.4 O2-Berechnungs-Karte

Format: A5

FLASCHENINHALT (Liter):

Druck (bar) × Volumen (L)

Beispiel: 5 L × 100 bar = 500 L

VORRAT (Minuten):

(Inhalt – Restdruck-Reserve) /

Verbrauch (L/min)

Beispiel: (500 – 150) / 2 L/min

= 175 min ≈ 3 h

Restdruck-Reserve: ca. 30 bar

SICHERHEIT:

- ☐ Kein Öl/Fett an Ventilen
- ☐ Schutzkappe auf Flasche
- ☐ Flasche in Befestigung
- ☐ Erst Ventil zu, dann Flowmeter zu

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018)

17.5 Lippenbremse-Anleitung

Format: A5

LIPPENBREMSE – bei Asthma-Anfall

1. Patient auffordern, langsam auszuatmen.
2. Lippen locker aufeinanderlegen, leicht spitz oder breitgezogen.
3. Ausatmung gegen den Widerstand der Lippen – 'puh wie auf eine heiße Suppe'.
4. Atemhilfsmuskulatur entspannt sich, Bronchien bleiben länger offen.

Übung: Strohhalm → Atem durch Nase ein, durch Strohhalm aus.

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018)

17.6 Hyperventilations-Rückatmung

Format: A5

RÜCKATMUNG – bei Hyperventilation

Indikation: Pfötchenstellung,
Karpfenmund, Kribbeln

1. Patient beruhigen (4-S-Regel!)
2. In Gespräch verwickeln
3. Kleine Plastiktüte über Mund +
Nase – max. 1–2 Minuten
4. Tüte vorher entleeren (kein
Sauerstoffentzug über die Norm)

ACHTUNG: Nicht bei Bewusstseinstrü-
bung, nicht bei Verdacht auf andere
Ursache (z. B. Herzinfarkt mit
Tachypnoe!).

Quelle: Begleitender Kommentar zur SanH-Ausbildung Modul B2 (JUH/BG/BEE 2018)

17.7 Blockhefter-Inhalt LF II (Erweiterung des Hefters aus LF